UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

OPHTALMOLOGIE
BAISSE D'ACUITÉ VISUELLE BRUTALE
Sans patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Chapus Elsa **Date de rédaction : 29/11/23**

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 138 – Anomalie de la vision

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Stratégie diagnostique

Domaine de compétence n°1 (en sélectionner 1 SEUL) : Synthèse des résultats d'examens paracliniques

Attendus d'apprentissage de la situation abordée (cf. LISA : Catégorie:Situation de départ NG — LiSA (uness.fr)**):**

1- Caractériser le trouble visuel

2- Identifier les situations nécessitant une prise en charge ophtalmologique en urgence

Patient simulé nécessaire à la station : NON

Matériel nécessaire à la station

- Mannequin NON
- Brancard NON
- IPad avec photos des examens complémentaires

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne aux urgences ophtalmologiques du CHU.

Vous recevez un patient de 65 ans pour baisse d'acuité visuelle brutale. Son œil est blanc et indolore, l'acuité visuelle est à l'œil gauche : 1/10ème et l'œil droit : 10/10ème.

PAS DE PATIENT

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Demander les examens complémentaires nécessaires au diagnostique et les interpréter

2. Enoncer le diagnostique précis et donner la prise en charge

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tache 1	
Demande un fond d'œil	
Demande une OCT (Tomographie à cohérence optique)	
Demande une angiographie à la fluorescéine	
Décrit le FO : œil gauche, papille, macula, vaisseaux rétiniens (au moins 3/4)	
Interprète le FO : œdème papillaire, veines tortueuses et dilatées, nodules cotonneux, hémorragies rétiniennes (au moins 3/4)	
Interprète l'OCT : œdème maculaire	
Interprète l'angiographie : territoires non perfusés = ischémie en noir, veines tortueuses et dilatées	
Tache 2	
Énonce le diagnostic : occlusion de la veine centrale de la rétine	
Précise la forme ischémique	
Énonce qu'il s'agit d'une urgence ophtalmologique	
Cite le traitement à prévoir : injections intravitréennes d'anti-VEGF, photocoagulation panrétinienne	
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	1 à 5
APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

	Pondération (entre 1 et 5)
Tache 1	
Demande un fond d'œil	5
Demande une OCT (Tomographie à cohérence optique)	2
Demande une angiographie à la fluorescéine	3
Décrit le FO : œil gauche, papille, macula, vaisseaux rétiniens (au moins 3/4)	2
Interprète le FO : œdème papillaire, veines tortueuses et dilatées, nodules cotonneux, hémorragies rétiniennes (au moins 3/4)	5
Interprète l'OCT : œdème maculaire	2
Interprète l'angiographie : territoires non perfusés = ischémie en noir, veines tortueuses et dilatées	2
Tache 2	
Énonce le diagnostic : occlusion de la veine centrale de la rétine	5
Précise la forme ischémique	3
Énonce qu'il s'agit d'une urgence ophtalmologique	3
Cite le traitement à prévoir : injections intravitréennes d'anti-VEGF, photocoagulation panrétinienne	3
COMPETENCES GENERIQUES	
APTITUDE À FAIRE LA SYNTHÈSE DES DONNÉES	Echelle de 1 à 5
APTITUDE À PLANIFIER LES SOINS	
APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE	